

TEMA 3.1 • OBSTETRICIA

Control Antenatal y Embarazo Fisiológico

PERFIL EUNACOM 2.01.2.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Control Antenatal y Embarazo Fisiológico

Frecuencia de los Controles

TABLA 3.1.1: PERÍODO VS FRECUENCIA

PERÍODO	FRECUENCIA
Diagnóstico → semana 28	Cada 4 semanas
Semana 28 → semana 36	Cada 2 semanas
Semana 36 → parto	Cada semana

Controles Clave y Exámenes

Control Inicial (1er trimestre, idealmente antes de semana 11)

Examen físico: PA, IMC, altura uterina, latidos cardio-fetales (eco).

- Laboratorio:
- Hemograma (anemia)
- Grupo sanguíneo y Rh → si Rh(-): prueba de Coombs indirecto
- VDRL/RPR (sífilis) — se repite 3 veces: inicio, sem 20–24, final
- VIH
- Chagas (desde Región de O'Higgins hacia el norte)
- TORCH: IgG para CMV y Toxoplasma (si negativas → sin inmunidad, hay riesgo)
- Glicemia en ayuno (screening diabetes)
- Sedimento de orina + urocultivo (bacteriuria asintomática: siempre tratar en embarazo)
- PAP (sin cepillado endocervical — riesgo de aborto; solo espátulado exocervical)
- Ecografía mamaria (no mamografía si < 40 años; o si hay nódulo)
- Ecografía: viabilidad, número de embriones, edad gestacional

Control Semanas 11–14

- Ecografía: Translucencia nucal (screening aneuploidías: Down, T18, T13)
- - Normal: < 3 mm
- Doppler de arterias uterinas (screening preeclampsia)
- - Si alterado: → iniciar Aspirina profiláctica

Control Semanas 20–24

- Ecografía morfológica (busca malformaciones fetales)
- Repetir Doppler de arterias uterinas (si alterado: indicar aspirina igualmente)
- Cervicometría (screening de parto prematuro)
- - Normal: ≥ 25 mm
- - Si < 25 mm: progesterona vaginal ± cerclaje (si antecedentes de abortos tardíos/parto muy prematuro)
- Repetir VDRL

Control Semanas 26–28

- TTGO (test de tolerancia a la glucosa oral) — screening diabetes gestacional
- - Basal normal: < 100 mg/dL; Poscarga (2h): normal < 140 mg/dL
- Repetir Coombs indirecto (si Rh-)
- ROGAM (gammaglobulina anti-D) si Rh(-) y Coombs indirecto negativo (no sensibilizada)
- Repetir ecografía morfológica (la de 28 semanas es la más importante)

Control Semanas 32–38

- Ecografía de crecimiento fetal (biometría, peso estimado)
- Repetir hemograma (anemia)

- Último VDRL

Control Semanas 35–37

- Cultivo vagino-perianal para Streptococcus agalactiae (Grupo B)
- - Si positivo → profilaxis antibiótica intraparto

Nutrición en el Embarazo

Incremento de peso recomendado

TABLA 3.1.2: IMC PREVIO VS INCREMENTO RECOMENDADO

IMC PREVIO	INCREMENTO RECOMENDADO
Bajo peso (< 18.5)	> 13 kg
Normal (18.5–24.9)	10–13 kg
Sobrepeso (25–29.9)	7–11 kg
Obesa (≥ 30)	5–9 kg

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El IMC normal en embarazada se considera entre 20–24.9 (un poco más estricto que en no embarazadas).

Suplementos (hay que saberse dosis)

TABLA 3.1.3: SUPLEMENTO VS DOSIS

SUPLEMENTO	DOSIS	INDICACIÓN
Ácido fólico	0.4 mg/día	Toda mujer que desea embarazarse (antes y durante)
Ácido fólico	4 mg/día	Diabéticas (gestacional o pregestacional) o antecedente de defecto tubo neural; embarazo gemelar
Hierro	30 mg/día (elemental) desde semana 16	Profilaxis anemia (≈ 1 cápsula sulfato ferroso 200 mg/día: 200 ÷ 5 = 40 mg hierro elemental)
Calcio	1 g/día (4–5 lácteos = 1 comprimido)	Todo el embarazo y lactancia
Vitamina D	Solo si vegana estricta, sin exposición solar, o raza negra	Grupos de riesgo de déficit

NOTA CLÍNICA

Las vitaminas prenatales en general NO tienen evidencia sólida que las respalde (excepto la vitamina D en grupos de riesgo). Lo que sí está recomendado son: ácido fólico, hierro y calcio.

Sulfato ferroso: Hierro elemental = dosis de sulfato ÷ 5. 200 mg sulfato ferroso = 40 mg hierro elemental.

Restricciones alimentarias

- Permitido: Pescado cocido ≥ 2 veces/semana (proteína omega-3)
- Contraindicado: Pescado crudo (anisakis) y especies con alto mercurio: albacora (pez espada), atún, blanquillo

Lactancia

- Calorías adicionales: 300–500 kcal/día
- Líquidos: 0.5–1 L/día adicional
- Calcio: 1 g/día (igual que en el embarazo)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"En relación a Control Antenatal y Embarazo Fisiológico: Cada 2 semanas | | Semana 36 → parto | Cada semana | --- ## Controles Clave y ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Control Antenatal y Embarazo Fisiológico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Frecuencia de los Controles
- Controles Clave y Exámenes
- Control Inicial (1er trimestre, idealmente antes de semana 11)
- Control Semanas 11–14
- Control Semanas 20–24
- Control Semanas 26–28
- Control Semanas 32–38

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONTROL ANTENATAL Y EMBARAZO FISIOLÓGICO)**PREGUNTA 1**

En relación a Control Antenatal y Embarazo Fisiológico: Cada 2 semanas | | Semana 36 → parto | Cada semana | --- ## Controles Clave y ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Control Antenatal y Embarazo Fisiológico se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Control Antenatal y Embarazo Fisiológico debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Control Antenatal y Embarazo Fisiológico requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Control Antenatal y Embarazo Fisiológico es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Control Antenatal y Embarazo Fisiológico no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Control Antenatal y Embarazo Fisiológico?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Control Antenatal y Embarazo Fisiológico. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: CONTROL ANTENATAL Y EMBARAZO FISIOLÓGICO

:::tip El IMC normal en embarazada se considera entre 20–24.9 (un poco más estricto que en no embarazadas). :::
 :::note Las vitaminas prenatales en general NO tienen evidencia sólida que las respalde (excepto la vitamina D en grupos de riesgo). Lo que sí está recomendado son: ácido fólico, hierro y calcio. Sulfato ferroso: Hierro elemental = dosis de sulfato ÷ 5. 200 mg sulfato ferroso = 40 mg hierro elemental. :::